ANESTESIA PRÁCTICA I

DR. GUSTAVO RAMBOA

CONCEPTO Y COMPONENTES

- Reducción escalonada, reversible y controlada de las funciones del SNC, con inconsciencia inducida farmacológicamente.
- 4 componentes: hipnosis (inconsciencia y amnesia anterógrada), analgesia/antinocicepción, inmovilidad y relajación muscular, estabilidad autonómica.
- El paciente inconsciente no "siente" dolor sino nocicepción, que se manifiesta vegetativamente (hipertensión, taquicardia, lagrimeo).

TIPOS DE ANESTESIA GENERAL

- Inhalatoria pura: mantenimiento exclusivo con agentes volátiles.
- TIVA (Total Intravenosa): propofol + remifentanilo exclusivamente.
- General balanceada: combina hipnótico IV + relajante + opioide + volátil; reduce dosis y efectos colaterales de cada fármaco.

MECANISMOS DE ACCIÓN

- Teoría lipídica (Meyer-Overton): a mayor liposolubilidad, mayor potencia.
- Teoría proteica (Franks y Lieb): interacción directa con GABA-A, NMDA, canales de Na+/K+; amnesia por GABA en hipocampo, inmovilización por bloqueo de Na+ medular.
- Agentes poco solubles en sangre (sevoflurano, desflurano): inducción y despertar más rápidos.

FASES DEL ACTO ANESTÉSICO

- Monitoreo básico: ECG, PANI, pulsioximetría, capnografía, temperatura.
- Preoxigenación: O2 100% por al menos 2 minutos antes de manejar la vía aérea.
- Inducción: hipnótico + opioide + relajante para intubación; secuencia rápida en estómago lleno, obesidad o embarazo.
- Mantenimiento y despertar: ajuste de concentraciones hasta suspender fármacos.

ETAPAS DE GUEDEL (ANESTESIA INHALATORIA)

- Etapa 1: analgesia. Etapa 2: excitación/delirio con hiperreactividad. Etapa 3: anestesia quirúrgica (4 planos). Etapa 4: parálisis bulbar, coma y muerte (debe evitarse).

CAM Y EVALUACIÓN ASA

- CAM: concentración que suprime respuesta motora en 50% de pacientes; a menor CAM, mayor potencia (Halotano 0.75%, Isoflurano 1.15%, Sevoflurano 2.0%, Desflurano 6.0%). Opioides reducen CAM hasta 30%.
- ASA: I sano, II enfermedad leve, III severa descompensada, IV amenaza constante de vida, V moribundo <24h, VI muerte cerebral.
- Principal causa de morbimortalidad: incapacidad para ventilar o intubar la vía aérea.

ESTADIOS DE LA ANESTESIA DE GUEDEL

Estadio		Respiración: Tórax	Respiración: Abdomen	Movimiento Ocular	Tamaño Pupilar	Reflejos: Párpado	Reflejos: Faríngeo	Reflejos: Corneal	Reflejos: Fotomotor	Tono Muscular Esquelético	Presión Arterial (PA)	Frecuencia Cardiaca (FC)	Usos y Observaciones
I Analgesia		forma de onda rítmica		Normal	Normal	Todos presentes				++	Ligeramente aumentado	++	Parto, cirugía menor
II Delirio o Excitación		Irregular, apnea por contener la respiración		Nistagmo	Dilatada	Presentes				++++	Aumentados considerablemente (++++) Descarga simpática	++++	Nulo (riesgo de laringoespasmo
III Anestesia Quirúrgica	1	Plano	Respiración superficial, rítmica.	Ojos fijos	midriática	Reflejo palpebral desaparece				+++	Altos	+++	Inicio de cirugía
	2	2	Respiración predominantemente abdominal	Ojos fijos	Dilatándose		Reflejo faríngeo desaparece			++	Disminuyendo	++	Mayoría de cirugías
	3	3	Respiración	Ojos fijos	midriática			Reflejo corneal desaparece		+	Bajos	+	Cirugía profunda
	4	4	Respiración superficial	Ojos fijos	Muy dilatada				Fotomotor desaparece	+	Bajos	+	No llegar nunca a este plano
IV Parálisis Medular (Sobredosis)		Apnea o parálisis respiratoria intercostal		Fijos	Midriasis paralítica (Totalmente dilatada, arreactiva)	Arreflexia total				Completamente relajado.	No registrable o hipotensión severa	No registrable o bradicardia severa	Coma o muerte. Es una emergencia.